SDD 54 Sujet n°1

Spécialité : Cardiologie

Date : 02/03/2024
Auteur : Gauthier Beuque
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2024 MAR Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	Synthèse de résultats d'examens paracliniques
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	330 - Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire
Situation(s) de départ en lien avec la station	054 - Oedème localisé ou diffus
Matériel nécessaire à la station	Résultat de bilan biologique
Contexte de la station	Organiser en cabinet la prise en charge d'un patient se présentant avec un œdème localisé du mollet et un dosage de D-dimères positifs.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e interne en médecine générale.
Vous recevez la patiente madame C., âgée de 26 ans au cabinet qui présente une jambe droite douloureuse associée à un œdème depuis 5 jours.
PA 123/71 mmHg, 58/min, 36,7°C, 99% SaO2, poids : 61 kg, taille : 169cm, IMC 21,3 kg/m2.
Elle est enceinte à 18 SA, est en bon état général et présente comme seul antécédent une appendicectomie à l'âge de 8 ans. Elle vous remet le résultat de la prise de sang que vous lui avez demandé de réaliser au laboratoire.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Expliquer à la patiente les résultats de la prise de sang et ce que cela implique
- Proposer et détailler l'examen complémentaire à réaliser pour le diagnostic
- Répondre aux questions de la patiente

Vous ne devez pas :

- réaliser d'examen clinique ;
- réaliser un interrogatoire ;
- proposer un traitement ;
- rédiger l'ordonnance.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	explique le mot thrombose ou caillot : bouchon de sang coagulé, bouchon de sang dur qui empêche le sang de circuler	1 pt
2.	Expliquer que le diagnostic le plus probable est une thrombose veineuse profonde (terme phlébite autorisé)	1 pt
3.	Expliquer comment se forme le caillot dans la veine OU triade de Virchow (hypercoagulabilité, stagnation sanguine, altération de la fonction intimale).	1 pt
4.	Expliquer que le diagnostic n'est pas encore posé par les D-dimères OU évoquer les performances diagnostiques (sensibilité, spécificité)	1 pt
5.	Expliquer que la patiente doit reconsulter en urgence en cas de signes d'EP (dyspnée, douleur thoracique, etc.)	1 pt
6.	Demander la réalisation d'une échographie-doppler veineux des membres inférieurs	1 pt
7.	Précise que l'échographie sera une échographie doppler	1 pt
8.	Explique que cet examen permettra de voir les vaisseaux de la jambe	1 pt
9.	Explique que l'examen doit être réalisé dans les jours qui viennent	1pt
10.	Explique que l'examen : - ne nécessite pas d'être à jeun - sera indolore - durera moins de 30 minutes ou sera rapide - sera réalisé par un radiologue	1pt
11.	Répondre "non" à la question sur les risques foetaux liés à cet examen	1pt
12.	Répondre "oui" à la question sur l'implication de la grossesse dans la TVP	1pt
13.	Expliquer simplement ce que sont les D-dimères avec des mots simples (activation de la coagulation, produit de dégradation de la fibrine, formation d'un caillot, etc.)	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	17 points

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

ECOS faisant essentiellement appel à des compétences de communication auprès du patient. Prenez donc le temps de bien expliquer, avec des mots simples, les éléments présentés ci-dessus. Vous en serez récompensés dans la section "communication et attitude".

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes une femme de 26 ans, enceinte à 18 SA, de retour chez le médecin traitant après avoir réalisé un dosage biologique (d-dimères) en raison d'une douleur spontanée dans la jambe droite associée à un gonflement.

Plan de la station ECOS :

La patiente est assise en face du bureau du médecin.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Bonjour docteur, je reviens vous voir après la prise de sang. J'ai toujours mal à la jambe droite et elle est gonflée."

Identité du patient :

Femme, madame Coulon, 26 ans, 169cm, 61kg

Mode de vie :

Professeure de français, mariée, 1 enfant et en attente du deuxième (enceinte à 18 SA), pas de toxique, pas d'allergie

Comportement global :

Sereine, calme, douleur au mollet droit

Antécédents personnels :

appendicectomie, G2P1

Antécédents familiaux :

aucun

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

aucun traitement de fond
prise occasionnelle de paracétamol pour soulager les douleurs de la jambe droite : efficace

Symptômes positifs :

douleur de la jambe droite (brûle, gêne, 3/10), gonflée.
pas d'autres symptômes

Constantes :

PA 123/71 mmHg, 58/min, 36,7°C, 99% SaO2

Donnée complémentaire :

Vous étiez venue il y a 5 jours en consultation pour oedème et douleur de la jambe droite ; à ce moment, le médecin vous avait prescrit une ordonnance pour une prise de sang que vous avez réalisée. Vous arrivez dans son bureau de consultation et vous asseyez en face de lui. Vous lui remettez les **résultats de la prise de sang**.

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

- Si le médecin ne propose pas de réaliser une échographie-doppler veineuse des membres inférieurs : demander "dois-je faire d'autres examens ?"
-
- Si le médecin ne le dit pas spontanément : demander "Est-ce que

l'échographie-**doppler** (insister sur doppler) présente un risque pour ma grossesse ?"

- Quand le médecin vous demande si vous avez des questions : " pourquoi on m'a dosé les DDimères ? Qu'est ce que c'est les DDimères ?"

- Si le médecin ne le dit pas spontanément : demander "Est-ce qu'il y a un lien entre ma grossesse et ma maladie ?"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Bureau : 1 médecin, 1 malade

Matériel nécessaire à la station :

- Résultats de la prise de sang

Documents présents dans la station :